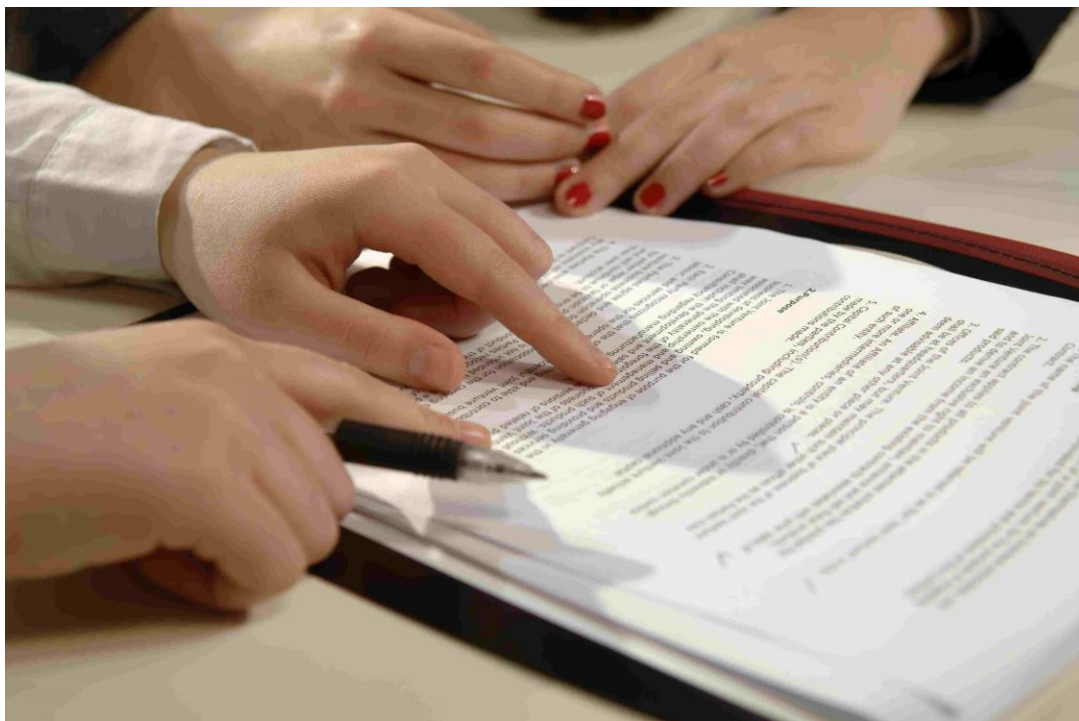


Guía de Suscripción Seguro VITAL 360

Dirección de Seguros Personales



15/05/2024

TABLA DE CONTENIDO

1.	GENERAL	3
2.	LINEAMIENTOS DE ASEGURAMIENTO.....	3
A.	ELEGIBILIDAD	3
B.	ASEGURAMIENTO DE ASEGURADOS DIRECTOS Y DEPENDIENTES	4
3.	LINEAMIENTOS DE SELECCIÓN DE RIESGOS	5
A.	SOLICITUDES DE SEGURO	5
B.	FIRMA DIGITAL	7
C.	SEXO E IDENTIDAD DE GÉNERO AUTOPERCIBIDA	7
D.	REQUISITOS DE ASEGURABILIDAD	8
E.	REQUISITOS DE COMPROBACIÓN DE ARRAIGO PARA RESIDENTES TEMPORALES SOLICITANTES DE PÓLIZAS DE GASTOS MÉDICOS.	8
F.	VIGENCIA DE LAS PRUEBAS DE SALUD	10
G.	TRATAMIENTOS A SOLICITANTES CON ENFERMEDADES O CONDICIONES QUE SE ENMARQUEN EN LA LEY 7600 DE DISCAPACIDAD	10
H.	INCLUSIÓN DE NIÑOS SUPERADO EL PERÍODO DE ESPERA POR EMBARAZO	14
I.	CASOS ESPECIALES	14
4.	LINEAMIENTOS DE APLICACIÓN DEL CONTRATO	16
J.	REHABILITACIÓN DE LA PÓLIZA	16
K.	RECONOCIMIENTO DE COMISIONES DE INTERMEDIACIÓN POR MIGRACIÓN A ESTE SEGURO.....	17
L.	HIJOS MAYORES DE 25 AÑOS EN EL CONTRATO	17
M.	LINEAMIENTOS DE TRASLADO EN PÓLIZAS DE GASTOS MÉDICOS	17

GUÍA DE SUSCRIPCIÓN SEGURO VITAL 360

Esta guía de suscripción regula las circunstancias en las que se podrá suscribir y, por tanto, contratar un seguro, partiendo del manual de aseguramiento del siguiente producto:

Registro ante la Superintendencia General de Seguros	
Producto	Vital 360
Número de registro y fecha de registro	P20-76-A01-1097 de fecha 03 de mayo del 2024
Categoría	Seguros Personales.
Ramo	Accidentes y Salud.
Modalidad de contratación	Individual.
Temporalidad del producto	Anual Renovable.
Tipo de contrato	Adhesión.

1. GENERAL

Este seguro se ofrece bajo modalidad individual únicamente.

2. LINEAMIENTOS DE ASEGURAMIENTO

A. ELEGIBILIDAD

1. **Una persona:** mayor de 18 años.
2. **Grupo familiar o dependientes:** el solicitante puede asegurarse con su grupo familiar, definido éste como:
 - a. El Asegurado Directo.
 - b. El cónyuge o conviviente del Asegurado Directo.
 - c. Los hijos siempre que sean solteros y que residan con el Asegurado Directo en el mismo domicilio, que sean dependientes económicamente, estudiantes y cuya edad no supere los veinticinco (25) años.
 - d. No se podrán incluir hijos mayores de 25 años, excepto, con capacidades especiales y que dependan económicamente del Asegurado Directo, para lo cual deberán presentar el certificado médico o cuando se justifique dependencia económica y según se haya pactado con el Tomador del Seguro.
3. **Otro tipo de dependientes (padres, hermanos, etc.):** deben mantener una dependencia económica con el Asegurado Directo.

B. ASEGURAMIENTO DE ASEGURADOS DIRECTOS Y DEPENDIENTES

Cuando un solicitante del seguro desee incluir a algún dependiente o a su núcleo familiar, podrán hacerlo siempre y cuando éste (el Asegurado Directo) se encuentre incluido en la póliza. Esto significa que no se podrán asegurar dependientes solos. Se establecen las siguientes excepciones:

I. Pólizas vigentes

Con respecto a las pólizas vigentes donde se hayan asegurado dependientes sin el asegurado principal, se procederá, en la renovación anual, de la siguiente manera:

1. Los dependientes que no cuenten con su asegurado principal pueden continuar asegurados sin éste.
2. Las nuevas inclusiones en la póliza, obligatoriamente, deben cumplir con el lineamiento supra citado.
3. Asimismo, en cuanto a las pólizas actuales que tienen el asegurado directo, no se permitirá su exclusión dejando únicamente al dependiente. Es decir, si el asegurado directo se va a excluir, también se excluirán sus dependientes, salvo que éste se esté trasladando a una póliza colectiva del INS.

II. Póliza colectiva sin aseguramiento de dependientes:

Cuando el asegurado directo está incluido en una póliza colectiva con el INS, la cual no contempla el aseguramiento de dependientes; previa corroboración de lo anterior, las alternativas son:

1. Que se asegure como directo el otro cónyuge y el hijo dependiente en otra póliza.
2. Si no existe cónyuge o conviviente o si éste se encuentra también asegurado en la póliza colectiva, se podrá asegurar el hijo dependiente solo, con el asegurado directo como nominal, en una póliza individual.

III. El asegurado directo desea adquirir la póliza junto con sus dependientes pero éste no es asegurable.

En este caso, se puede autorizar, también por la vía de excepción, aplicar los puntos anteriores.

3. LINEAMIENTOS DE SELECCIÓN DE RIESGOS

A. SOLICITUDES DE SEGURO

I. La declaración de salud tiene carácter de declaración jurada ante la compañía aseguradora y en un eventual litigio judicial, de manera que debe ser recibida en condiciones óptimas de nitidez, claridad y legibilidad, que no dejen dudas sobre su autenticidad y propósito. Los documentos deben ser originales (físicos o digitales). No se recibirán solicitudes con respuestas ambiguas que dejen duda, guiones, tachaduras, etc.

II. Los formularios de aseguramiento son:

1. **Solicitud de Seguro Vital 360:** Este formulario se utiliza para recopilar la información tanto del Asegurado Directo como sus dependientes. En el caso de que éstos sean menores de 18 años, el solicitante incluirá sus datos e información en el apartado de Datos del Asegurado. Este documento cuenta con dos espacios para las firmas de mayores de edad, en caso de que se solicite la inclusión de 3 o más dependientes mayores de 18 años deberán completar otra solicitud.

III. Para cualquiera de los casos anteriores, la solicitud deberá cumplir con los siguientes puntos:

1. Deberá completarse en su totalidad, dictada o llenada por el Asegurado Directo o el Dependiente en caso de ser mayor de edad; también podrá completarla el Intermediario de Seguros u otra persona según el dictado del Asegurado, quien al final revisará el formulario a fin de verificar que la información contenida es correcta y firmará el documento. El formulario deberá ser llenado con lapicero o pluma, en un mismo color de tinta (azul o negro). Se exceptúa cuando existe un prellenado completo de parte del intermediario en una tinta y posteriormente el solicitante firma con otro color; esto en el entendido que el asesor le explica claramente lo que está firmando y le realiza las preguntas que ahí se consignan.
2. La solicitud podrá completarse a mano o en formato editable.
3. Se debe consignar el nombre, fecha, firma con número de cédula y código del intermediario de seguros; es indispensable que se anoten los cuatro datos.
4. No se debe presentar con más de sesenta (60) días naturales de cumplimentada la misma. Caso contrario, se requerirá aportar una nueva solicitud de seguro.
5. Se autoriza la firma digital, de acuerdo con lo que indica el apartado Firma Digital de esta Guía.

GUÍA DE SUSCRIPCIÓN SEGURO VITAL 360

6. A la solicitud de seguro o cualquier otro formulario que se utilice, se deben adjuntar el formulario de autorización para consulta de expedientes y entrega de información Confidencial y el “Cuestionario Covid”.
7. Para las inclusiones de nuevos asegurados se debe indicar el número de póliza.
8. Cuando en la solicitud de seguro se indique en forma afirmativa cualquiera de los padecimientos que se citan a continuación, deberá presentar el cuestionario que corresponda, debidamente.

Cuestionario	Padecimiento o condición
Cuestionario sobre afecciones de Vejiga, Vías Urinarias y/o Próstata	Afecciones de la próstata, vejiga y vías urinarias
Cuestionario sobre uso de bebidas alcohólicas y Alcoholismo	Alcoholismo
Cuestionario sobre Covid - 19	Se solicita en todos los casos que requieren el proceso de Selección de Riesgos
Cuestionario sobre Diabetes	Diabetes Mellitus tipo I y tipo II
Cuestionario sobre Enfermedades Gastrointestinales	Enfermedades del esófago, Hernia hiatal, Enfermedades del estómago o intestinos, Sangrado digestivo, Gastritis, Úlcera gástrica o duodenal, Colitis, Enfermedades del recto o ano, Enfermedades del hígado, Piedras u otra enfermedad en la vesicular biliar
Cuestionario sobre Epilepsia	Convulsiones y/o epilepsia
Cuestionario sobre Hipertensión Arterial	Presión arterial Alta
Cuestionario sobre quistes, masas, formaciones anormales y tumores	Presencia de quistes, masas, formaciones anormales y tumores
Cuestionario sobre condiciones del Sistema nervioso y/o estrés	Depresión, Ansiedad y/o nervios, Estrés, Enfermedades mentales de cualquier tipo
Cuestionario sobre trastornos lumbares / de espalda	Enfermedades de la columna vertebral, Hernia de la columna vertebral, Lumbago y/o Ciática, Escoliosis u otra deformidad en su columna, Dolor persistente o crónico de espalda
Cuestionario sobre trastornos respiratorios	Enfermedades de los pulmones, asma, bronquitis, enfisema, enfermedad obstructiva crónica de vías aéreas, Tuberculosis, etc.
Tumores de próstata (para el médico tratante)	Tumor de próstata diagnosticado
Cuestionario de Consumo de Sustancias	Consumo de cualquier consumo de sustancias psicotrópicas y/o drogas

B. FIRMA DIGITAL

La Ley 8454, Certificados, firmas digitales y documentos electrónicos permite el uso de la firma digital en Costa Rica.

Por lo tanto, se permite la firma digital, tanto en las solicitudes de aseguramiento de pólizas, como en las declaraciones médicas. Asimismo, el trasiego de información por parte de intermediarios o proveedores médicos.

Condiciones de aceptación de la firma digital por parte del funcionario que recibe el documento:

- I. Se autoriza únicamente la firma digital certificada a través del Banco Central de Costa Rica. Ésta debe ser validada con la herramienta dispuesta en INS Colaboradores para tal efecto. Si la firma resulta no válida, el documento no se acepta.
- II. Cualquier documento firmado digitalmente se requiere de forma magnética, no impreso ya que de esta forma es imposible validar la firma.
- III. Si el cliente firma digitalmente y bloquea el formulario, la solicitud puede ser remitida por el intermediario, si éste no cuenta con el dispositivo, vía correo electrónico o por los medios tecnológicos disponibles, indicando que da fe de que vio a la persona a asegurar y que, al menos en apariencia, goza de buena salud.
- IV. Si el cliente firma digitalmente y no bloquea el formulario, el intermediario puede hacerlo, remitiéndolo posteriormente por correo.

C. SEXO E IDENTIDAD DE GÉNERO AUTOPERCIBIDA

En la actualidad, no es posible comprobar el sexo de una persona, ya que no se solicita el documento de identidad para la emisión de seguros y, además, los nuevos documentos carecen de la identificación del sexo. El solicitante simplemente declara su sexo, el cual puede o no coincidir con el asignado al nacer.

Siendo que, definitivamente, existen diferencias en la mortalidad y morbilidad entre hombres y mujeres, se establecen los siguientes lineamientos:

- I. Si la persona (intermediario o empleado de ventanilla) que ofrece el seguro o completa la solicitud, tiene alguna duda respecto al sexo indicado por el solicitante, debe hacer la consulta, de manera que el sexo que se consigne en el documento debe ser el asignado al nacer.
- II. En los casos donde se pueda corroborar el sexo en el Registro Civil, la Sucursal procederá con dicha verificación.

GUÍA DE SUSCRIPCIÓN SEGURO VITAL 360

- III. El riesgo se clasificará de acuerdo con el sexo asignado desde su concepción, independientemente de la autopercepción que, de sí misma, tenga la persona.
- IV. Si el asegurado ya cuenta con un seguro y desea cambiar su sexo y nombre, se le podrá cambiar el nombre en el sistema, mas no el sexo ya que de éste depende la tarificación del seguro.
- V. La cirugía de cambio de sexo es una exclusión del contrato de gastos médicos, ya que se trata de una cirugía electiva, no una enfermedad.

Cada caso debe valorarse de manera individual, teniéndose mucho cuidado de no generar situaciones discriminatorias para este segmento de la población.

D. REQUISITOS DE ASEGURABILIDAD

Se establece la siguiente tabla de requisitos de asegurabilidad:

REQUISITOS PARA COSTARRICENSES, RESIDENTES PERMANENTES Y TEMPORALES	
EDAD DEL SOLICITANTE	REQUISITOS
De 18 a 65 años	Solicitud de seguro
De 66 a 70 años	Solicitud de seguro y entrevista dirigida (Telesuscripción)
De 71 años en adelante	Solicitud de seguro y batería de exámenes (*)
(*) Batería de exámenes mayores de 71 años inclusive: Examen médico, Uroanálisis, Electrocardiograma de reposo y valoración cardiovascular, Hemoglobina glicosilada, Glicemia en ayunas, Enzimas hepáticas (ALT, AST, GGT), Bilirrubina total (directa e indirecta), Creatinina, Perfil de Lípidos, Antígeno prostático (hombres), Examen de sangre oculta en heces (Guayaco).	
A criterio del Selector de Riesgos se solicitarán pruebas médicas o no médicas (examen médico, electrocardiograma de reposo, pruebas de laboratorio, cuestionario de alcoholismo, trastornos respiratorios, diabetes, epilepsia, hipertensión arterial, sistema nervioso, úlcera, trastornos lumbares, etc.	
Los exámenes corren por cuenta del Instituto y únicamente deben realizarse con proveedores autorizados. Cualquier otro examen o prueba adicional que se requiera para la selección de riesgos será pagada por el solicitante.	

E. REQUISITOS DE COMPROBACIÓN DE ARRAIGO PARA RESIDENTES TEMPORALES SOLICITANTES DE PÓLIZAS DE GASTOS MÉDICOS.

1. Residentes Temporales:

- a. Deben presentar fotocopia de la cédula de residencia emitida por la Dirección General de Migración y Extranjería o DIMEX, o bien, el Carné de Refugiado. El DIMEX es el Documento de Identidad Migratoria para Extranjeros con el que Migración dota a los foráneos legalmente establecidos en nuestro país.

GUÍA DE SUSCRIPCIÓN SEGURO VITAL 360

- b. Para los solicitantes de los planes Locales y Regionales se permitirá la presentación de copia del pasaporte vigente.
- c. Para aquellas personas que soliciten un plan internacional y que no cuentan con cédula de residencia o DIMEX, Carné de Refugiado, o que su estado migratorio sea de condición restringida, pero que residen en Costa Rica, deben demostrar su arraigo mediante alguna de las siguientes condiciones:
 - i. **Trabajador en Costa Rica:** debe aportar carta del patrono donde indique el período del contrato. En estos casos, podría aceptarse el pasaporte o el Permiso Laboral de Refugiado, como excepción. Si el solicitante es su propio patrono, debe demostrar otro tipo de arraigo de los aquí señalados.
 - ii. **Estudiante en Costa Rica:** debe presentar carta del Centro Educativo donde se compruebe el período de matrícula, que conste que es estudiante regular y el plan de estudios que seguirá.
 - iii. **Arraigo en Costa Rica:** debe presentar una certificación de la CCSS que indique desde cuándo la persona está cotizando para esa entidad. Se aceptará como mínimo dos años de cotizaciones.
 - iv. **Que sea cónyuge o conviviente de un costarricense o extranjero residente permanente,** (según lo definen los arts. 73 y 73 bis de la Ley de Migración y Extranjería), ambos con más de tres años de vivir en Costa Rica.
- d. Para las personas extranjeras que residen de manera permanente en Costa Rica pero no puedan demostrar el arraigo según los puntos anteriores y optan por un seguro con ámbito internacional, se podrá brindar el seguro con la presentación de la copia del pasaporte bajo las siguientes condiciones:
 - i. En caso del que el cliente permanezca más de cuatro (4) meses fuera de Costa Rica, los gastos que se generen posterior a este período no serán amparados por la póliza.
 - ii. El Instituto se reserva la potestad de solicitar los requisitos correspondientes para la verificación de esta condición.

Para ello se confeccionará el adendum que se entregará en la emisión del seguro.

Nota: No se realizarán traslados de asegurados de los planes Local y Regional a los planes Internacional si no cumplen con los requisitos anteriores, independientemente del tiempo con que cuenten en el plan Local o Regional.

2. Residente en el Exterior:

En el caso de Residentes Temporales en el Exterior: Es asegurable solamente en pólizas colectivas no contributivas donde la empresa cuenta con empleados extranjeros trabajando también en el exterior.

En este caso las pruebas de asegurabilidad que se soliciten corren por cuenta del solicitante, así como el En este caso las pruebas de asegurabilidad que se soliciten corren por cuenta del solicitante, así como el apostillado de los mismos.

F. VIGENCIA DE LAS PRUEBAS DE SALUD

La vigencia de la declaración y pruebas de salud que hayan sido practicadas por médicos y laboratorios autorizados es de 90 días naturales, contados a partir del día en que fueron realizados, de manera que, una vez transcurrido ese plazo, las pruebas no son válidas para efectos de seleccionar un riesgo.

G. TRATAMIENTOS A SOLICITANTES CON ENFERMEDADES O CONDICIONES QUE SE ENMARQUEN EN LA LEY 7600 DE DISCAPACIDAD

Se deben tomar en cuenta varios aspectos de la realidad nacional:

- I. Ley 7600: "Igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad", la cual en su artículo 37 indica:

"ARTÍCULO 37.- Imposibilidad de negar seguros de vida o pólizas.

No podrá negarse la adquisición de un seguro de vida o una póliza de atención médica, basándose exclusivamente en la presencia de una discapacidad".

- II. Se define discapacidad como *cualquier deficiencia física, mental o sensorial que limite sustancialmente, una o más de las actividades principales de un individuo.*

Una discapacidad puede deberse a:

1. Un accidente
2. Una enfermedad
3. Una condición, cualquiera que sea su origen.

III. Niños nacidos producto de una reproducción asistida:

Está demostrado médicamente que los niños nacidos producto de una reproducción asistida presentan una incidencia mayor de enfermedades o condiciones, por lo que se hace necesaria una valoración especial en todos los casos a fin de tarifarlos adecuadamente.

El contrato póliza indica lo siguiente:

CLÁUSULA XXXII. EDAD DE CONTRATACIÓN Y DE COBERTURA

“... Hijos nacidos en el seguro, es decir, producto de un parto cubierto por esta póliza, para ser incluidos en el seguro deben presentar la Solicitud del Seguro dentro de los treinta (30) días naturales después de su nacimiento y presentar una constancia de nacimiento dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha del nacimiento. En estos casos no se aplicará el período de espera indicado en las Condiciones Particulares.

En el caso de niños nacidos en un parto cubierto por esta póliza como resultado de un tratamiento de infertilidad y/o esterilidad, así como los niños nacidos fuera del seguro, si la persona asegurada directa desea incluirlo en la póliza, deberá presentar la solicitud del seguro, para continuar con el procedimiento habitual de aseguramiento. Podrán incluirse a partir del día treinta y uno (31) de su nacimiento”

Para la correcta aplicación de este lineamiento se establece:

1. Recepción de solicitudes de aseguramiento en la Sucursal:

La solicitud contiene las siguientes preguntas:

- * ¿El embarazo se produjo como resultado de cualquiera de los siguientes métodos de reproducción asistida, independientemente de la causa o razón para aplicarlo:
 - Fecundación in vitro (FIV)
 - Inseminación artificial (IA)
 - Inyección intracitoplasmática de espermatozoides. (ICSI)
 - Otro método de reproducción asistida. ¿Cuál?

GUÍA DE SUSCRIPCIÓN SEGURO VITAL 360

- * Indique si el (los) solicitante (s) ha (n) sufrido o sufre (n) de alguna de las siguientes enfermedades o condiciones genéticas. Marque con una x en cada casilla.

-SI NO Síndrome de Down

-SI NO Otra condición genética.

Según lo indica el contrato póliza, si el parto fue cubierto por el seguro, la solicitud debe ser presentada dentro de los 30 días naturales después del nacimiento. No obstante:

1. Si el solicitante declara positiva la pregunta sobre reproducción asistida: La Sucursal debe devolver la solicitud con la indicación de que ésta se debe cumplimentar hasta el día 31 del nacimiento y en ese momento trasladar a la Unidad de Selección de Riesgos para continuar con el proceso.
2. Si el solicitante declara positiva la pregunta sobre Síndrome de Down o Condición genética, la Sucursal debe trasladar la solicitud a la Unidad de Selección de Riesgos para continuar con el proceso.
3. Si, por el contrario, el solicitante declara negativa alguna de las preguntas anteriores:
 - a. La Sucursal debe verificar que el parto fue cubierto por la póliza, a través del sistema administrador de reclamos.
 - b. Procederá con la inclusión del niño en la póliza.

2. Recepción de solicitudes de aseguramiento en la Unidad de Selección de Riesgos:

1. Síndrome de Down u otra condición genética: (parto cubierto):

- a. Se debe solicitar el historial clínico, el cual, una vez analizado:
 - i. Por la condición, el médico asesor determinará el recargo que corresponda.
 - ii. Si el solicitante cuenta con otras enfermedades asociadas, deberán valorarlas, lo cual puede significar un recargo adicional, posponer o inclusive, declinar el seguro.
- b. Los casos con montos mayores a \$1.000.000 deberán ser remitidos a la Unidad Técnica Especializada para su valoración.

2. Síndrome de Down u otra condición genética: (parto no cubierto):

Estos son los casos donde el parto no fue cubierto por la póliza y cuya solicitud debe presentarse posterior a los 31 días del nacimiento. También se puede tratar de un parto cubierto por la póliza, pero cuya solicitud se presenta luego de los 30 días del nacimiento.

- a. Se debe solicitar el historial clínico, el cual, una vez analizado:
 - i. Por la condición, el médico asesor determinará el recargo que corresponda.
 - ii. Si el solicitante cuenta con otras enfermedades asociadas a la condición, éstas se considerarán preexistentes, por lo que se pueden excluir, recargar, posponer o inclusive, declinar el seguro. Si el contrato es de preexistencias, se clasificará el riesgo dependiendo de las condiciones particulares de la póliza.
- b. Los casos con montos mayores a \$1.000.000 deberán ser remitidos a la Unidad Técnica Especializada para su valoración.

3. Niños producto de un tratamiento de reproducción asistida: (parto cubierto o no):

La solicitud será valorada en la Unidad de Selección de Riesgos, realizando la selección, ya sea que se trate de un parto cubierto o no, según corresponda a cada caso.

4. Solicitudes que no presentan ninguna de las condiciones anteriores:

La Unidad de Selección de Riesgos procede con la clasificación de riesgo según corresponda.

3. Aseguramiento de adultos con discapacidad:

En estos casos aplica lo correspondiente al apartado “Síndrome de Down u otra condición genética (parto no cubierto).”

4. Continuidad en traslados de pólizas con aumento de monto asegurado:

1. Se le brindará tratamiento igual que cualquier otro aumento de póliza, es decir, sublimitando los diagnósticos de la póliza anterior.
2. No se podrá sublimitar el Síndrome de Down o condición genética relacionada, como tal.

H. INCLUSIÓN DE NIÑOS SUPERADO EL PERÍODO DE ESPERA POR EMBARAZO

Si una Asegurada embarazada ha cumplido su período de espera por Maternidad en la póliza y utiliza el beneficio, ya sea en gastos prenatales o en el nacimiento, podrá solicitar la inclusión del niño (a) dentro de los 30 días naturales de nacido, otorgando así cobertura al menor desde la fecha de nacimiento; con la salvedad descrita en el aparte anterior “Tratamiento de casos dentro de la Ley 7600 de discapacidad” y lo establecido en la Cláusula de edad de contratación de las Condiciones Generales del contrato. En los casos donde la asegurada, por alguna circunstancia, teniendo el derecho al beneficio de Maternidad, el nacimiento del niño (a) es atendido a través de la seguridad social, podrá presentar la solicitud de inclusión del niño (a) dentro de los 30 días naturales de nacido, otorgando así cobertura al menor desde la fecha de nacimiento.

El niño (a) deberá ser incluido en la póliza de la madre; sin embargo cuando la madre esté incluida en una póliza colectiva con el INS, la cual no contempla el aseguramiento de dependientes; previa corroboración de lo anterior, las alternativas son:

- I. Si se trata de una disminución de monto o éste permanece igual (dentro de los planes disponibles en seguro individual), debe presentar una carta indicando el plan escogido y la forma de pago, dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de nacimiento del menor.
- II. Si, por el contrario, se trata de un incremento de monto asegurado, se debe presentar la solicitud de aseguramiento y completar los requisitos de asegurabilidad que correspondan y someterse al proceso de selección de riesgos.

I. CASOS ESPECIALES

Según acuerdo de la Sesión No. 83 del Comité de Reaseguros y Retenciones del 22 de diciembre de 2022, no se cuenta con contrato de Reaseguros para los contratos de gastos médicos y cualquier suscripción será retención total del INS.

En virtud de lo anterior, para efectos del aseguramiento de casos especiales se establece lo siguiente:

I. Riesgos subnormales:

1. Recargos menores o iguales a 200%: la Unidad de Selección de Riesgos clasificará el riesgo, sin necesidad de remitirlo a la Unidad Técnica Especializada.
2. Recargos mayores a 200%: la Unidad de Selección de Riesgos clasificará el riesgo, sin necesidad de remitirlo a la Unidad Técnica Especializada. Se deberá marcar en el sistema transaccional con el fin de poder identificar los contratos.

II. Riesgos no asegurables:

Las empresas suelen ofrecer seguros de salud a sus empleados como parte de sus beneficios laborales, por lo que resulta necesario brindar alguna opción de aseguramiento a cada uno de ellos. También puede suceder que una persona estuvo asegurada en una póliza de salud colectiva y, por alguna circunstancia, sale de dicha póliza y solicita un seguro individual.

Si alguna persona resulta no asegurable, se valora el caso considerando la opción que permita la mejor contención del gasto, ya sea con exclusiones o sublímites, tomando en cuenta las condiciones de la póliza.

La Unidad de Selección de Riesgos clasificará el riesgo según las características de este, en conjunto con los médicos asesores, y tomando en cuenta las características de la póliza. De acuerdo con el monto asegurado, se procederá de la siguiente manera:

1. Montos menores o iguales a \$100.000 o ¢55.000.000: Si aplican las condiciones de la Guía, la Unidad de Selección de Riesgos clasificará el riesgo, sin necesidad de remitirlo a la Unidad Técnica Especializada.
2. Montos asegurados mayores de \$300.000 o ¢165.000.000: Si aplican las condiciones de la Guía, la Unidad de Selección de Riesgos clasificará el riesgo y lo remitirá a la Unidad Técnica Especializada con la propuesta de aseguramiento.
3. Para montos asegurados de \$1.000.000 o ¢550.000.000: la Unidad Técnica Especializada remitirá el informe al Comité de Reaseguros y Retenciones para el análisis correspondiente.

En caso de que el riesgo se acepte, deberá ser marcado en el sistema por la Sucursal con el código que se le indique en el oficio de aceptación. La Dirección de Operaciones remitirá a la Dirección de Seguros Personales, de forma mensual, un detalle de los casos especiales aceptados y vigentes. Esto con el fin de contar con el listado actualizado de los casos especiales vigentes.

4. LINEAMIENTOS DE APLICACIÓN DEL CONTRATO

J. REHABILITACIÓN DE LA PÓLIZA

El Asegurado podrá solicitar la rehabilitación de su póliza por medios propios, sus representantes o intermediarios de seguros. La aceptación de rehabilitar el seguro estará sujeta a las siguientes condiciones:

- I. Debe presentar la solicitud escrita dentro de los treinta (30) días naturales siguientes a la fecha de cancelación de la póliza, con indicación de:
 1. Causas que imposibilitaron el pago de la renovación de la póliza en el tiempo establecido.
 2. El estado actual de salud tanto del Asegurado Directo como de su grupo familiar asegurado.
- II. Si la forma de pago de la póliza es diferente a la anual, se debe verificar la aplicación del artículo 37 de la Ley del Contrato del Seguro. Si se aplicó el artículo se hace la siguiente valoración:
 1. Compromiso de pagar las primas que quedaron al descubierto.
 2. El seguro debe tener una vigencia mínima de dos (2) años continuos.
 3. Se debe analizar la experiencia siniestral de la póliza. Se debe valorar el motivo del gasto con el fin de determinar si obedece a causas accidentales o a padecimientos crónicos o catastróficos. La póliza debe presentar una experiencia siniestral general no mayor al 50% y, en el último año, no mayor al 50%. La ocurrencia de cualquiera de las dos imposibilita su rehabilitación.
- III. No haber solicitado rehabilitación de la póliza durante el último año ininterrumpido de su vigencia.

El Instituto se reserva el derecho de otorgar o no un nuevo aseguramiento, de acuerdo con la potestad que le brinda la Ley Reguladora del Mercado de Seguros N° 8653, artículo 52.- Instituto Nacional de Seguros.

No obstante lo anterior, si el Instituto no comunicó la cancelación del seguro, según lo establece el artículo 37 – Mora en el pago, de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros, y la póliza se cancela, ésta se debe rehabilitar de oficio, debiendo el asegurado pagar las primas pendientes a la fecha. (se debe realizar una valoración caso a caso).

K. RECONOCIMIENTO DE COMISIONES DE INTERMEDIACIÓN POR MIGRACIÓN A ESTE SEGURO

Las pólizas que se emitan como parte de una migración de personas aseguradas provenientes de otros seguros de gastos médicos del Instituto, deberán emitirse con comisión de renovación, según se establece en el esquema de comisiones aprobado para este producto.

L. HIJOS MAYORES DE 25 AÑOS EN EL CONTRATO

Los hijos que cumplan la edad máxima de cobertura antes del vencimiento anual del seguro, se mantendrán cubiertos hasta la próxima renovación anual, previo pago de la prima correspondiente.

Una vez que alcance los 25 años, si el Tomador de seguro (persona asegurada directa) brinda su anuencia de que dicho dependiente continúe asegurado en la póliza, se deberá proceder de la siguiente manera:

- A la póliza hija del joven se le cambia el estatus de “Hijo” a “Otro Dependiente”, agregando en “Comentarios” que se trata del hijo que es mayor de 25 años y se aplica la prima que le corresponda según rango de edad.

M. LINEAMIENTOS DE TRASLADO EN PÓLIZAS DE GASTOS MÉDICOS

Los asegurados actuales en pólizas de salud pueden solicitar el traslado a otro producto diferente, para lo cual se valorará, ya sea la continuidad de cobertura y/o el reconocimiento de la antigüedad del seguro anterior.

1. Clientes que ya cuentan con un seguro INS:

- a. Se brindará el beneficio de antigüedad en el cual se reconocerá el tiempo transcurrido desde su inclusión en la póliza anterior para los efectos del cumplimiento de la Cláusula de Períodos de espera de las Condiciones Generales y Particulares, para hacer uso del seguro. Si el asegurado cuenta con varios seguros anteriores del Instituto, se deberá valorar desde la fecha de inclusión en estos seguros. En este caso, la permanencia en los contratos debe ser de forma ininterrumpida entre cada uno.

Este reconocimiento no aplica para trasplantes. En los seguros individuales tampoco aplica para maternidad.

- b. Se brindará continuidad a los padecimientos, condiciones o accidentes que surgieron durante la vigencia de una póliza INS, sin interrupción de ésta, hasta por los límites o coberturas definidos en la póliza anterior o el nuevo contrato (el monto o sublímite menor de los dos según corresponda), siempre y cuando el nuevo contrato cuente con la cobertura para que éstas sean amparadas.

Para los efectos se entenderá como preexistencia todo padecimiento, accidente o condición con que cuenta un asegurado (cliente) con anterioridad a la inclusión en una póliza del INS. Se excluye de esta definición aquellos padecimientos, accidentes o condiciones que surgieron durante la vigencia continua de una póliza INS.

2. Clientes nuevos (no INS) con póliza vigente con otra aseguradora:

- a. Se brinda el reconocimiento de antigüedad (el tiempo transcurrido desde la fecha de la última póliza vigente) para el levantamiento de los períodos-establecidos en la Cláusula Períodos de espera de las Condiciones Generales y Particulares.

No aplica para trasplantes. En los seguros individuales tampoco aplica para maternidad.

Este reconocimiento no incluye el amparo de padecimientos, accidentes o condiciones que sean anteriores a la inclusión del asegurado en el nuevo seguro. Si el nuevo contrato cuenta con la cobertura de Preexistencias se realizará la valoración respectiva.

A. Parámetros generales:

Requisitos para iniciar el trámite:

1. El asegurado deberá presentar la solicitud de seguro dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de exclusión de la póliza o del vencimiento anual.
2. Los traslados se permitirán solamente en la renovación anual. Se exceptúan los siguientes casos:
 - a. Si el asegurado se traslada al extranjero por más de seis meses en cuyo caso requiere cambiar de seguro.

- b. Si un asegurado solicita su inclusión o exclusión en una póliza colectiva, debido a cambios de patrono, despido, renuncia, pensión o jubilación.

3. Para el seguro Vital 360, adicionalmente se aplicará lo siguiente:

- a. Solicitudes de seguro – Clientes INS:

Al tratarse de un seguro distinto, todas las personas deberán llenar la solicitud establecida para este producto. No obstante, para el llenado del formulario se define (aplica para todos los planes):

- i. Si se trata de disminución o se mantiene el monto asegurado con respecto a la póliza anterior, se deberá complementar la solicitud, con excepción de los apartados: “Aspectos relacionados con el riesgo”, “Información sobre salud de (de los) solicitante (s) de ser necesario adjuntar solicitud adicional”, es decir, se exime al asegurado que tenía seguro anterior de completar los apartados correspondientes a la declaración de salud. Además, se exonera la presentación del formulario COVID.
- ii. Si se trata de aumento de monto: se deberá llenar el formulario completo.

- b. Solicitudes de seguro - Clientes de otra Aseguradora: deberán completar el formulario completo.

Todos los traslados deberán ser elevados y valorados por la Unidad de Selección de Riesgos.

Para los Planes Platinum 2 y Deluxe que cuentan con la cobertura de Preexistencias Declaradas, se determina:

- Las preexistencias que serán cubiertas serán las que sean declaradas por el cliente y aceptadas por el Instituto, por lo cual serán valoradas en el proceso de Selección de Riesgos.
- Los diagnósticos excluidos en INS Medical o Seguro Médico Colectivo Contrato Tipo, se mantendrán como una exclusión para el Seguro Vital 360 y no entrarían dentro de la cobertura de Preexistencias Declaradas.
- Se trasladan los recargos por sobrepeso, fumado, combinación de factores de riesgo y por sub-normalidad que tenían en el seguro anterior.

- Asimismo, no serán asegurables como preexistencias declaradas todas las enfermedades de alto impacto y que se mencionan a continuación:

1. Enfermedades metabólicas:

- a. Diabetes mellitus complicada con micro y macroangiopatía.
- b. Diabetes insípida
- c. Amiloidosis
- d. Obesidad mórbida (IMC mayor o igual a 40)

2. Enfermedades oncológicas:

- a. Cualquier tumor maligno y/o metastásico.

3. Enfermedades neurológicas:

- a. Epilepsia refractaria con indicación quirúrgica.
- b. Esclerosis lateral amiotrófica, múltiple, tuberosa
- c. Miastenia Gravis.
- d. Hidrocefalia.
- e. Enfermedad cerebro vascular
- f. Síndromes de compresión medular como hernias de núcleo pulposo, hematomas de canal medular
- g. Traumatismos de espina dorsal con sección o compresión medula
- h. Enfermedad de Alzheimer
- i. Atrofia muscular espinal juvenil, neural progresiva
- j. Demencia
- k. Distrofia muscular
- l. Enfermedad de Parkinson
- m. Malformaciones arteriovenosas cerebrales

4. Enfermedades oftalmológicas:

- a. Retinopatía
- b. Neuritis Retrobulbar.
- c. Glaucoma agudo y crónico.
- d. Degeneración Macular
- e. Uveítis

5. Enfermedades cardiovasculares

- a. Enfermedades cardíacas reumáticas y/o autoinmunes crónicas como Enfermedad de Buerger, Enfermedad de Kawasaki, Granulomatosis de Wegener, Poliarteritis nodosa. Cardiopatía reumática, valvulopatías, etc.
- b. Cardiopatía isquémica, angina de pecho e infarto agudo del miocardio.
- c. Insuficiencia Cardíaca
- d. Miocardiopatías de cualquier etiología
- e. Malformaciones cardíacas congénitas
- f. Aneurismas
- g. Arritmias cardíacas con importancia clínica como bloqueos completos de rama, síndrome de Wolf Parkinson White, Fibrilación o taquicardias Atriales o Ventriculares.
- h. Bloqueo auriculoventricular
- i. Bloqueo sinoauricular
- j. Síndrome de Brugada
- k. Intervalo QT prolongado
- l. Insuficiencias, estenosis valvulares
- m. Enfermedad arterial periférica

6. Enfermedades respiratorias

- a. EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica)
- b. Hipertensión pulmonar
- c. Fibrosis pulmonar
- d. Apnea del sueño
- e. Alveolitis alérgica extrínseca
- f. Asma grave persistente
- g. Enfermedad pulmonar intersticial difusa

7. Enfermedades del aparato locomotor

- a. Artrosis, anquilosis
- b. Patología de columna vertebral, hombros, rodillas, caderas, pelvis, muñecas, tendones, ligamentos
- c. Politraumatismo.

8. Enfermedades digestivas

- a. Cirrosis hepática.
- b. Varices esofágicas.
- c. Colitis Ulcerativa Crónica Inespecífica (CUCI)
- d. Enfermedad de Crohn.

- e. Esófago de Barrett con presencia de displasia.
- f. Enfermedad de Wilson
- g. Hepatitis C y B estadio crónico

9. Enfermedades Urogenitales renales

- a. Insuficiencia renal aguda y crónica.
- b. Malformaciones renovasculares y del aparato excretor.
- c. Enfermedad de cambios mínimos
- d. Enfermedad poliquística renal
- e. Glomerulonefritis membranosa, semilunar idiopática
- f. Nefrocalcinosis
- g. Síndrome nefrótico
- h. Vejiga neurogénica

10. Enfermedades autoinmunes

- a. Síndrome antifosfolípido
- b. Lupus Eritematoso Sistémico complicado.
- c. Purpura trombocitopénica idiopática
- d. Hepatitis autoinmune
- e. Espondilitis anquilosante
- f. Artritis reumatoidea
- g. Polimialgia reumática
- h. Polimiositis
- i. Síndrome de Sjögren
- j. Esclerosis sistémica difusa
- k. Arteritis de Takayasu
- l. Poliarteritis nodosa
- m. Vasculitis

11. Enfermedades infecciosas

- a. Infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana.

12. Trasplantes de cualquier órgano.

13. Condiciones congénitas

- a) Síndrome de Down

14. Otras patologías

- a) Consumo de drogas
- b) Psoriasis
- c) Fibromialgia

15. Hematológicas

- a) Agranulocitosis
- b) Anemia aplástica
- c) Hemocromatosis
- d) Anemia hemolítica

16. Enfermedades mentales

- a. Depresión y Ansiedad
- b. Trastorno del neurodesarrollo y del espectro autista
- c. Esquizofrenia
- d. Trastorno bipolar

B. Casos que deben ser considerados por la Sucursal que administra el contrato:

En pólizas de INS Medical, los traslados que involucren cambio de deducible dentro del mismo producto, ya sea en ámbito Regional o Internacional, no requieren de selección de riesgos, se tramitan en la Sucursal.

C. Procedimiento para las Sucursales, posterior a la aceptación del traslado:

1. El Asegurado debe efectuar el pago de primas correspondientes al período transcurrido entre la terminación de la cobertura del plan anterior y la fecha en que se hace efectiva la nueva póliza, de acuerdo con las primas vigentes y la edad. En el seguro de INS Medical la edad correspondiente al más próximo cumpleaños del asegurado en el nuevo contrato.
2. En caso de que hubiera primas no devengadas, éstas se aplicarán a la nueva póliza. Adicionalmente, el condicionado de seguros establece que cuando existan reclamos indemnizables de la prima pagada de ese Asegurado en la póliza de una o varias personas o núcleos asegurados, se retendrá el cien por ciento (100%) de la prima pagada de esa persona asegurada en la póliza.
3. La Sucursal deberá cancelar la póliza anterior y emitir la nueva póliza, de manera que no quede ningún período al descubierto; esto con el fin de dar continuidad al

GUÍA DE SUSCRIPCIÓN SEGURO VITAL 360

seguro. Si se trata de seguros administrados por Sucursales diferentes, éstas deben coordinar el proceso de cancelación de la póliza anterior.

A continuación, se presentan los escenarios posibles y su tratamiento:

Tipo de traslado						
Cambios	Aumento de monto	Disminución de monto	Mismo monto asegurado	Aumento o disminución de monto traslado a Seguros con cobertura de Preexistencias Declaradas	Aumento o disminución de monto de pólizas con preexistencias a contratos sin preexistencias	Cuerpo Diplomático a cualquier otro seguro
Monto Asegurado:	Aumenta	Disminuye	Mantiene	Aumenta o disminuye	Aumenta o disminuye	Se mantiene / Disminuye
Lleva Siniestralidad:	Si	No	No	Si	Si	No
Cambian Condiciones:	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Lleva Selección:	Si	No	No	Si	Si	Si
Continuidad:	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Observaciones:	Se deben determinar sublímites (se cubren las patologías hasta el monto de la póliza anterior)	Las Sucursales deben mantener los recargos y/o exclusiones de la póliza anterior	Las Sucursales deben mantener los recargos y/o exclusiones de la póliza anterior	Se deben determinar sublímites en caso de aumento (se cubren las patologías que surgieron en el seguro anterior hasta el monto de la póliza anterior). Se deben determinar las patologías preexistentes a las cuales se brindará cobertura y recargos (en los casos en que aplique)	Se otorga únicamente el reconocimiento de antigüedad para los períodos establecidos en la Cláusula de Períodos de Espera. Así lo deberá indicar el Selector de Riesgos en la aceptación del nuevo seguro.	Se debe analizar las condiciones del nuevo seguro y definir si el cliente es o no un riesgo asegurable y si se aplican exclusiones o recargos. No corresponde aplicación de sublímites y únicamente se aplica el levantamiento de períodos de espera. Si la persona asegurada contaba con seguros anteriores se deberán valorar los diagnósticos cubiertos en estas pólizas para brindar la continuidad respectiva.

Nota: Todos los traslados de asegurados en el Seguro Vital 360 deberán ser elevados y valorados por la Unidad de Selección de Riesgos.

D. Continuidad de cobertura para chequeos en pólizas INS

Se deberá revisar si la póliza anterior o la nueva cuentan con cobertura de chequeos y los períodos de espera de cada póliza, bajo los siguientes escenarios:

- Asegurados con cobertura en póliza anterior de chequeos, póliza nueva sin cobertura de chequeos: al no tener la póliza nueva los chequeos, no aplican.

- b. Asegurados en póliza anterior sin cobertura de chequeos, póliza nueva con chequeos: aplican los chequeos tal y como se negoció, es decir, se debe aplicar el período de espera establecido en el nuevo contrato.
- c. Póliza anterior con chequeos, póliza nueva con chequeos: se reconocerá el tiempo transcurrido desde la inclusión en el seguro anterior, para los asegurados que cuentan con el beneficio en la póliza anterior.

E. Aseguramiento en una póliza de gastos médicos cuando un cliente viene de otra compañía aseguradora diferente al INS (del extranjero o no)

Cuando un cliente viene de una compañía aseguradora distinta al INS no se brinda continuidad de cobertura de los padecimientos, sino que se valora el reconocimiento de la antigüedad para el levantamiento de los períodos de espera, para lo cual debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Constancia de la compañía aseguradora donde indique las fechas del aseguramiento (desde y hasta) y el detalle de las personas aseguradas.
2. Presentar un informe de la compañía anterior que detalle los siniestros cubiertos en la póliza anterior, el cual debe indicar diagnóstico, monto pagado y fecha de los gastos. Si el solicitante no consigue obtener el historial siniestral, debe indicarlo así, por escrito.
3. La póliza de la otra compañía aseguradora debe estar vigente, no en período de gracia, sin excepción.
4. Efectuar el pago de las primas correspondientes al período transcurrido entre la terminación de la cobertura del seguro de la otra compañía aseguradora y la fecha en que se hace efectivo el levantamiento de los períodos de espera de acuerdo con las primas vigentes y la edad. Para INS Medical la edad correspondiente al más próximo cumpleaños del Asegurado en el nuevo contrato.
5. La fecha de emisión del nuevo seguro será a partir del día siguiente de la cancelación del seguro anterior.
6. Se revisará la siniestralidad y se efectuará la selección de riesgos a fin de determinar los términos en que se podría emitir el seguro, en caso de que se cuente con la misma.
7. Períodos de Espera:
 - a. Se brinda el reconocimiento de antigüedad (el tiempo transcurrido desde la fecha de la última póliza vigente) para el levantamiento de los períodos establecidos en la Cláusula Períodos de espera de las Condiciones Generales y Particulares.
 - b. No aplica para trasplantes. En los seguros individuales tampoco aplica para maternidad.

8. Chequeos:

- a. El chequeo aplica de acuerdo con lo establecido en el nuevo contrato; es decir, se otorgará hasta que supere el período indicado en las Condiciones Particulares del nuevo seguro.

Notas importantes que aplican para los lineamientos de traslados anteriores:

Dada la gran variedad de situaciones que se pueden presentar, el análisis y criterio del selector de riesgos cobran vital importancia para la revisión de cada caso, por lo que se pueden establecer otras condiciones de aseguramiento, bajo sus criterios técnicos.

Adicionalmente, de acuerdo con la potestad que le brinda la Ley Reguladora del Mercado de Seguros No. 8653, artículo 52.- Instituto Nacional de Seguros, el Instituto se reserva el derecho de otorgar o no un nuevo aseguramiento.